

12 - 02- PROCTOLOGIE PÉDIATRIQUE - Pr. FOURAIJI

(0:01 - 3:30)

Bonjour, aujourd'hui on va voir un chapitre intitulé Proctologie pédiatrique qui regroupe un ensemble de pathologies qui sont dans la plupart bénignes et qui peuvent nécessiter un traitement médical ou chirurgical et aussi certaines pathologies qui vont nous guider vers des pathologies plus générales. C'est un chapitre qui est important et qui est plus souvent un motif de consultation pédiatrique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça regroupe un ensemble de pathologies dont le substratum anatomico-commun c'est qu'il touche la région recto-anale de l'enfant.

Dans la plupart des cas c'est des pathologies bénignes qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire bénignes, c'est-à-dire que le traitement peut être juste médical, qui une fois traité peut disparaître. Et le diagnostic il repose essentiellement sur l'examen de la marge anale, sur l'examen de la région périnéale. Et l'examen de la marge anale de la région périnéale est un temps essentiel dans l'examen de tout enfant car il peut déceler des pathologies qui ne sont pas le motif de consultation et qui font partie intégrante de l'examen de tout enfant.

Chez le grand enfant il pourra verbaliser la pathologie, il pourra verbaliser les signes, mais chez le tout petit, le nouveau-né ou le nourissant c'est délicat et donc on va se baser sur les dires des parents ou bien encore mieux sur l'examen clinique, donc sur l'examen de la région anale. Et ces pathologies, dont la plupart sont des pathologies bénignes, elles peuvent cacher certaines pathologies chroniques, on le verra par la suite. Elles regroupent un ensemble de pathologies dans les plus importantes, donc la jugée nécessaire pour le cours C, le prolapsus rectal, le polyprectal, l'abcès et la fissure.

L'objectif du cours c'est essentiellement de savoir reconnaître ces lésions anorectales lors de l'examen. Il est essentiel de faire l'examen de la marge anale chez tout enfant et donc on doit les reconnaître et aussi préciser la façon de les traiter. Donc la région qui est intéressée par la proctologie pédiatrique, c'est la région anorectale, la partie terminale du rectum et la partie de l'anus, avec tout le complexe qui est autour sphinctérien, donc le sphincter interne, sphincter externe, avec le muscle, le releveur de l'anus et l'espace cellulaire ici, d'accord, l'espace péréal, donc c'est là où se fait une grande partie des communications, surtout quand on parle de fistules anales, et donc tout ce complexe est mis en jeu dans cette proctologie pédiatrique en fonction de la pathologie qu'on va voir par la suite.

(3:31 - 10:56)

Donc premier chapitre qu'on va commencer, c'est le prolapsus rectal. C'est quoi ce prolapsus rectal? Le prolapsus rectal c'est quoi? C'est l'issue d'une partie de la paroi rectale à travers l'anus, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la paroi rectale, c'est-à-dire, quand on dit paroi rectale,

on dit avec toutes les composantes de la paroi, c'est-à-dire la muqueuse, la musculuse, la sphinctérie muqueuse, et donc qui vont glisser à travers l'anus, donc sortir à travers l'anus, et on va les retrouver à l'examen clinique. Et ces prolapsus, il y a deux types, il y a un type muqueux et un prolapsus total.

Ça veut dire quoi prolapsus muqueux? Prolapsus muqueux, c'est-à-dire qu'il y a juste la muqueuse qui a glissé et qui va se retrouver au niveau de l'anus. Par contre, le prolapsus total, c'est toute la paroi du rectum qui va s'invaginer et va sortir à travers l'anus qu'on va retrouver à l'examen clinique. Mais heureusement, le prolapsus muqueux, il est le plus fréquent, on le retrouve dans 95% des cas, c'est un prolapsus qui est muqueux, et on va voir par la suite pourquoi on a ce prolapsus.

Il survient chez les deux sexes, les deux enfants peuvent être atteints de prolapsus rectal, dont la plupart du temps il est muqueux, il survient entre l'âge de 1 à 5 ans, son qui est prédominant, donc les deux sexes sont atteints. Pour comprendre ce prolapsus, il y a certains facteurs qui peuvent favoriser ce glissement de la paroi rectale et qui va se retrouver au niveau de l'anus. On peut avoir des facteurs anatomiques, ce qui veut dire que soit la muqueuse rectale est lâche, donc elle s'invagine facilement, elle va glisser facilement, on la dépose pour que le rectum épouse la concavité de sa crotte, si elle est rectiligne, elle va favoriser le glissement de cette muqueuse ou de la paroi rectale, donc il y a deux facteurs anatomiques, soit elle est lâche, soit on a la concavité sacrée qui n'est pas concave mais qui est plutôt rectiligne, ou bien on peut avoir aussi des facteurs fonctionnels, ça veut dire quoi fonctionnel, ça veut dire que c'est un enfant qui est assis sur le pot, qui va pousser de toute façon très très fort, et en poussant très fort, il va faire descendre la paroi rectale, qui va passer dans la lumière, la lumière anale, et on la retrouve à l'extériorisé, et c'est poussé, ils sont favorisés chaque fois qu'on a un problème de constipation, donc soit c'est un enfant qui reste longtemps sur le pot, il y a des mamans qui laissent leur enfant, lors de l'apprentissage de la propreté, donc ils laissent leur enfant longtemps assis sur le pot, et bien ça, ça favorise le prolapsus, parce que l'enfant est assis et il pousse, ou bien lors de la constipation, et bien lors de la constipation aussi, les enfants, ils augmentent la pression intra-abdominale, et donc ils vont pousser le rectum vers le bas, et favoriser le prolapsus, ou bien des celles qui sont sèches, donc les celles qui sont sèches, lors de la descente, elles tirent avec elles la muqueuse rectale, et on va se retrouver avec un prolapsus.

Donc des fois, le prolapsus rectal, donc soit il est dû à des facteurs anatomiques, ou bien des facteurs fonctionnels, d'accord, ou bien il peut faire partie d'un tableau, et qu'on va retrouver lors d'une pathologie telle qu'une constipation, donc un enfant qui est constipé le plus souvent, il peut faire, développer un prolapsus rectal, et il va faire partie, d'une fois que vous a traité la constipation, le prolapsus va disparaître. Ou bien, une diarrhée, donc des celles qui sont liquidiennes, avec une augmentation du péristaltisme aussi, du péristaltisme intestinal, donc rectal, on va avoir le passage de la muqueuse rectale, ou bien de la musse, donc dans le prolapsus, ou bien une dysurie, dysurie, qui dit dysurie, dit augmentation de la pression intra-

abdominale, donc lors des poussées, l'enfant il va pousser, donc il va pousser aussi sur son rectum, et il va favoriser ce prolapsus. La mucoviscidose, la mucoviscidose parce qu'elle nous donne un assèchement, un assèchement de celles, donc on a un assèchement des celles, et donc des celles qui sont dures, qui vont favoriser, qui vont coller à la muqueuse rectale, et ils vont entraîner avec eux, cette muqueuse, et favoriser le prolapsus.

Alors, la même chose, quand on a un effort de tour, donc l'effort de tour, ça augmente, ça donne une augmentation de la pression intra-abdominale, donc ça favorise aussi le prolapsus, et vous comprenez très bien, quand on a une agilisie sacrée, donc agilisie sacrée, qui dit agilisie sacrée, dit il n'y a pas de sacrum, donc on parlait tout à l'heure d'un sacrum qui n'est pas concave, il va favoriser le prolapsus, ici il n'y a pas de sacrum, et donc aussi ça favorise le prolapsus, pourquoi? Parce que le sacrum, donc on a la concavité, donc le rectum il doit épouser la concavité du sacrum, et aussi on a le musculo-pharocyste de l'anus et tout, donc tout ceci, on n'a plus le complexe qu'on a vu tout à l'heure dans l'anatomie, qui est respecté. Donc reprenez, que ce qui favorise le prolapsus, ça peut être des facteurs anatomiques, ou fonctionnels, ou étiologiques, donc quand on a un prolapsus, il faut penser, est-ce que c'est une simple constipation, dans la plupart des cas, est-ce qu'on a des diarrhées, ou bien on a une augmentation de la pression intra-abdominale lors des diésuries, ou des poussées lors de la position sur le pot, donc en poussant sur le pot, ou bien on a une pathologie de la muqueuse, donc pathologie en rapport avec la mucoviscidose, avec un assèchement des selles, donc la mucoviscidose, tout ceci pour dire que le prolapsus peut cacher certaines étiologies. Alors le diagnostic, il est diagnostic clinique, soit c'est un enfant qui, lors de l'examen, on retrouve un enfant normal, on ne voit rien, et on va se baser sur les dires des parents, et la maman, elle va vous dire qu'à chaque fois qu'il fait ses selles, elle a une sortie d'un cylindre de muqueuse qui est rouge, lors de la défécation, ou bien après celle-ci, et la mère elle est formelle, chaque fois qu'il va partir à la selle, on a quelque chose qui sort de l'anus et qui est rouge tout le temps, donc c'est permanent pour elle, donc chaque fois qu'il fait ses selles, donc elle le voit, soit lors de la défécation, soit après, et des fois les parents vont le réintégrer à la main.

(10:57 - 24:34)

Donc ce prolapsus, il peut être long, de 2 à 5 cm, avec issue de muqueuse, ou bien des fois de sang, et c'est juste, il n'y a pas de douleur, mais c'est juste, il va gêner, donc les parents vont se poser la question, c'est quoi ceci, de quoi il s'agit, des fois ils viennent, ils sont alarmés, ils ont peur, quelque chose qui sort lors de la défécation, donc ça les fait peur, ou bien il y a aussi un peu de sang qui se retrouve dans la culotte de leur enfant, donc il ne donne pas de douleur, mais c'est surtout une gêne. Alors la réintégration, comme on l'a dit tout à l'heure, la maman peut la faire par une simple pression, par les doigts, ou bien elle fait une réintégration spontanée, donc ça disparaît de façon spontanée, mais ce qui gêne le plus souvent et qui pose des problèmes, c'est qu'ils récidivent, donc chaque fois, chaque selle, on va avoir ce cylindre, ce cylindre qui sort lors de la défécation, donc chaque fois c'est la même chose, c'est la même chose. Alors ce

prolapsus, comme on l'a dit, il peut être soit lors de la défécation, soit des fois on le retrouve à l'examen, donc on le retrouve à l'examen clinique, bien sûr l'examen va porter sur un examen général, comme on l'a dit tout à l'heure, le prolapsus peut cacher certaines pathologies chroniques, telles que la mucoviscidose, il faut faire attention, il faut examiner s'il n'y a pas d'autres problèmes, s'il n'y a pas un problème d'ingénieur sacré, etc, et rechercher la constipation, donc les antécédents de constipation, depuis quand il y a ces constipations, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que ça fait partie d'une pathologie chronique, ou est-ce que c'est juste une constipation liée à une erreur diététique, etc.

Rechercher aussi la notion de diarrhée, est-ce que ce prolapsus est apparu au décours d'une diarrhée, ou bien depuis longtemps, et ça il faut se poser la question, rechercher s'il y a des fécalodes qu'on rencontre lors de la constipation, et surtout, surtout, il faut examiner la marge anale et le canal anal. Donc la marge anale, il faut déplacer ce prolapsus, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, pour le plus souvent on a une marge anale qui est saine. Alors, dans 20% des cas, quand on a des prolapsus qui sont associés à une constipation et qui inquiètent les parents, donc on peut trouver une mucoviscidose, et donc ça peut être un signe d'alerte, signe d'alerte, toujours rechercher, le prolapsus associé à une constipation, est-ce qu'il n'y a pas d'antécédents de mucoviscidose, est-ce qu'il n'y a pas de signe respiratoire, et voir aussi, est-ce qu'il n'y a pas l'aspect des selles, comment il est, est-ce que c'est des selles qui sont gras, massives, rechercher aussi une distension abdominale, et rechercher la notion de constipation chronique, et surtout faire le test à la sueur qui va être positif, et donc là, le prolapsus n'était qu'un symptôme de la mucoviscidose.

Donc toujours, toujours, penser, quand on a une constipation chronique qui peut donner un prolapsus comme ça, penser à la mucoviscidose, c'est vrai qu'elle n'est pas très rare dans notre contexte, mais il faut y penser à la mucoviscidose. Surtout elle s'est associée à d'autres signes. Alors, il faut, comme on l'a dit, examiner la marge anale, il faut examiner la marge anale, le canal anal, il faut déplacer aussi, pour rechercher aussi un ulcère rectal, donc une ulcération au niveau de cette muqueuse rectale qui est prolapsée, et ou bien un polype.

Alors les complications du prolapsus, elles sont rares et exceptionnelles, qu'on va trouver des complications, tels qu'un petit saignement, donc une hémorragie basse, ou bien une rectite, donc une inflammation de cette paroi, avec une supériorité, donc on peut trouver du pus, etc, mais c'est vraiment exceptionnel, ou bien un étranglement, mais tout ceci reste exceptionnel. Donc plus souvent, ce qui gêne dans le prolapsus rectal, c'est cette sortie, et les parents, ils sont rapidement alertés dès que la maman, elle voit qu'il y a quelque chose de rouge qui sort à chaque défécation, donc il faut savoir poser de bonnes questions, la recherche, de signes, soit d'anomalies, donc une constipation, une diarrhée, une dysurie, donc tout ce qui peut nous orienter, ou bien nous orienter vers, soit une étiologie, donc telle que mucoviscidose, dysurie, ou bien problème de diarrhée, etc, ou bien un problème anatomique, telle qu'une agénésie sacrée, une anomalie de la concavité sacrée, aussi qui peut donner un prolapsus, ou bien donc

des celles qui sont sèches, donc mucoviscidose. Donc pour le traitement, ça va être, il va reposer sur les principes, bien sûr, de ce qu'il donne, donc on va éviter ce qui donne le prolapsus, donc éviter la poussée excessive, et diminuer l'adhérence du bol fécal, donc plus le bol fécal il est sec, plus il adhère à la muqueuse, plus il va l'attirer avec lui lors de la défécation, et plus on a une augmentation de la pression intra-abdominale, plus on peut avoir donc un prolapsus.

Donc éviter la mise au pot en posissant acropie, et éviter de garder l'enfant longtemps sur le pot, les mamans elles veulent que leur enfant soit propre, mais ceci peut être une erreur, surtout si on laisse l'enfant longtemps en posissant acropie sur le pot. Ne pas insister sur la propreté, laissez les choses venir avec leur temps. Proposez plutôt des toilettes avec un réducteur pour les défécations jambes pendantes chez l'enfant, donc on met un réducteur sur les toilettes et on les fait asseoir, et non pas en position acropie, la position acropie augmente le risque de prolapsus.

Faire une réduction du prolapsus par un pressant manuel qui est douce, du boudin qui permet sa réintégration, et associer un lubrifiant et un laxatif osmotique pour éviter l'adhérence du bol focal, donc traiter la constipation. Il faut traiter la constipation et éviter les facteurs favorisant le prolapsus rectal. Le traitement se fait pendant 3 à 6 mois, d'accord, et si le prolapsus il récidive systématiquement après un traitement bien suivi, alors on peut indiquer ce qu'on appelle des injections sclérosantes.

Pourquoi injections sclérosantes? On va injecter un produit sous la muqueuse pour favoriser l'adhérence de la muqueuse rectale à la paroi, le reste de la paroi du rectum, puisqu'on a dit dans 95% c'est un prolapsus muqueux, donc il faut garder cette muqueuse à coller au reste de la paroi, donc par des injections sclérosantes. On va pratiquer trois séances successives, espacer 2 à 3 semaines, on injecte 3h, 6h, donc à 9h, donc à des points qui sont bien précis sur le cercle de l'anus, donc en sous-muqueux, et après on va voir est-ce que ça donne des résultats ou pas. Si ça récidive tout le temps, même avec les produits sclérosants, donc on va être obligé d'aller jusqu'au niveau des processus chirurgicaux, et ça peut être un type de cerclage de l'anus, ou bien une électrocoagulation de la muqueuse rectale, ou bien des procédés de suspension rectale, une rectoplastie, ou bien une résection sigmoïdienne, tout ceci est rare, et surtout donc des fois juste la simple réintégration du prolapsus de façon douce, juste le traitement de la constipation, juste en évitant les facteurs qui favorisent le prolapsus rectal, le prolapsus disparaît, et au maximum on va arriver au produit sclérosant, donc il est exceptionnel d'arriver au traitement chirurgical.

Pour les prolapsus secondaires, si on a une diarrhée, il faut donner un traitement spécifique de la diarrhée, donc il faut faire déjà le bilan, à savoir la coproparasitologie des selles, si on confirme qu'il y a une étiologie propre à la diarrhée, donc on donne le traitement spécifique. La mucoviscidose disparaît, donc le prolapsus disparaît après le traitement d'une instance pancréatique externe, et pour les malformations anorectales, le prolapsus récidivement va nécessiter une réévaluation chirurgicale, ça c'est parce qu'on a un problème anatomique, donc quand on a vraiment un problème anatomique, on va arriver rapidement au traitement chirurgical.

Par contre, s'il s'agit d'une simple concipation ou d'une déposition qui favorise le prolapsus, la première partie du traitement suffit largement pour faire disparaître le prolapsus rectal.

La deuxième pathologie qu'on retrouve le plus souvent chez l'enfant, c'est le polype rectal. C'est quoi ce polype rectal ? Le polype, c'est quoi ? C'est une tumeur bénigne, c'est une excroissance au niveau de la muqueuse rectale, et c'est une formation qui est bien limitée, tissulaire, qui peut être de quelques millimètres ou bien jusqu'à une dizaine de millimètres, donc un centimètre, et qui peut être soit accolé à la muqueuse, on appelle une polype qui s'essie, ou bien elle a un pédicule, donc un pied, on appelle pédiculé, qui peut être aussi unique, et donc c'est le polype solitaire, polype rectal solitaire, ou isolé, ou bien elle peut être multiple et qui peut rentrer dans le cadre d'une pathologie qu'on avait appelée la polypose. Donc les différents types de polypes chez l'enfant, il y a des polypes de type amartomateux, ou bien adénomateux, ou bien mixtes inflammatoires.

Donc amartomateux, c'est le plus fréquent, c'est le polype juvénile isolé, donc un seul polype, on va retrouver, on va enlever, le problème est réglé. Ou bien on peut trouver plusieurs, et on va parler de la polypose juvénile, ou le syndrome de Petzger, qu'on va voir par la suite. Donc les différents types, soit amartomateux, soit adénomateux, bien on peut trouver les deux composants, c'est-à-dire des glandes, et le reste de la parlante.

Donc ou bien on peut avoir un adénome isolé, donc le type adénomateux isolé, ou bien une polypose adénomateuse familiale, donc c'est les deux choses. Donc soit c'est un polype juvénile isolé, soit il est isolé, soit il est multiple, et la même chose pour les adénomes. Alors, ils se différencient de quoi ces polypes ? Donc de leur origine, on va dire histologique, mais aussi, ils vont siéger où ? Donc ils siègent, soit ils peuvent être soit au niveau du rectum, et de façon isolée, on a un seul polype au niveau du rectum, une fois qu'on va enlever, le problème est réglé, ou bien on va retrouver plusieurs polypes, donc ils peuvent être au niveau du rectum, au niveau du sigmoïde, ou même le reste du côlon.

Ils peuvent être isolés, ou bien associés à d'autres lésions extra-digestives, qu'on va voir par la suite, et on a dit qu'il y a deux types de polypes, amartomateux ou adénomateux, mais le plus fréquent, celui que vous allez retrouver le plus, c'est le polype juvénile solitaire, un seul polype, une seule excroissance au niveau de l'ampoule rectale, qui peut être même retrouvé au toucher rectal. Donc le plus fréquent, c'est le polype juvénile isolé. Alors le polype juvénile isolé, il va être fréquemment, on va le retrouver entre l'âge de 2 à 12 ans, le plus souvent, il est unique, il siège au niveau du rectum dans 70% des cas, donc au niveau du rectum, on va le retrouver, et on va le retrouver même des fois, soit il est extériorisé lors de la selle, ou lors des poussées, donc les parents ils viennent vous dire, on a retrouvé une petite masse qui sort et qui rentre, qui ne s'aime pas, etc, rougeâtre chez notre enfant, ou bien, on va le retrouver aussi lors de cygnes, lors de cygnes, à savoir, lors de rectoragie récidivante, lors des selles, et ce qu'on appelle, c'est le signe que l'on va retrouver, le signe du dentifrice, le signe de cygne, c'est-à-dire qu'on a des traînées

rougeâtres lors des selles, donc ça signe qu'il y a peut-être une masse intrarectale qui s'aime, à chaque fois, on va trouver des rectoragies, à chaque selle, on va retrouver des rectoragies sous forme linéaire, et donc les parents, ils vous le décrivent très bien, et quand ils la ramènent à l'examen.

(24:36 - 27:19)

Alors ici, quand on a ce signe, quand on pense à la polype, il faut rechercher les antécédents familiaux, est-ce que dans la famille, il y a cette notion de polype, est-ce qu'il n'y a pas d'autres lésions, et quand est-ce qu'il sort, est-ce qu'il y a une extériorisation spontanée, ou même, des fois, la mère vous le ramène, donc lors de poussées de selles, on a une élimination de petite masse rougeâtre, qui, rougeâtre, arrondi, qui, pour certains enfants, les parents vous disent, avant, il sortait, et on ne le retrouvait plus après la selle, mais maintenant, il a été éliminé, donc soit l'examen, on va le retrouver, donc l'examen, on va examiner la marge anal, et donc soit les parents, ils vont vous dire, il est extériorisé, il se réintègre lors de selles, ou bien, soit on va le voir, le retrouver, ou bien, c'est aux touches rectales, qu'on va mettre, aux touches rectales, on va palper une masse intra-rectale qui est ferme, mobile, qui peut être même ramenée au niveau de l'anus, et on va l'enlever, d'accord? Quand on examine, et quand on a tous les signes cliniques, donc c'est-à-dire qu'à chaque selle, on a des saignements, qui sont rapportés par la mère, aux touches rectales, on n'arrive pas à percevoir ce polype, auquel on y a pensé, donc ça, on parle d'un polype qui est inaccessible, et là, on passe à faire une rectosigmoidoscopie, et on va voir la localisation du polype, d'accord? Donc c'est un polype juvénile isolé, on va retrouver un seul polype, qu'on pourra enlever à l'exérèse à l'ance, ou bien à la pince diadermique, donc après coagulation, on va enlever ce polype, en général, c'est une lésion bénigne, donc le polype juvénile isolé, c'est une lésion qui est bénigne, donc il n'y a pas de risque de cancérisation, en général, il n'y a pas de suite, d'accord? Mais on a un risque de récurrence, donc 16% des cas. Et ce polype qui est juvénile, il est différent d'une polyposose du type, donc quand on a plusieurs polypes, on parle d'une polyposose, et cette polyposose, elle peut rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome de Pest-Jäger, où on, à l'examen, on va retrouver une polyposose mutipe, mais on va aussi retrouver ce qu'on appelle des petites tâches caféolées, lenticulaires, au niveau, en périanal, et aussi au niveau de la bouche, donc ça c'est si, un cortex, et en général, la famille, elle connaît la pathologie, et elle vous dit qu'on a des antécédents familiaux de polyposose. Le troisième chapitre qu'on retrouve très fréquemment dans la proctologie rectale, c'est les abcès et les fistules anaux.

(27:19 - 35:12)

Les abcès et les fistules anaux, c'est quoi? Donc l'abcès c'est quoi? C'est secondaire à une infection de quoi? Des canaux glandulaires qui se trouvent au fond des cryptes de Morgagni, et c'est une infection qui se propage vers la marge anale. Elle est faite de quoi? Donc, on a des glandes ici, donc des glandes qui sont autour du canal anal, donc les canaux glandulaires, qui normalement s'ouvrent ici, donc ils vont s'infecter, et on aura une communication, donc on aura

une abscédation, une abscédation aussi de ces canaux glandulaires, et qui peuvent s'ouvrir, donc elles peuvent s'ouvrir au niveau de la muqueuse anale, et elles peuvent s'ouvrir aussi à l'extérieur, d'accord? Ces fistules, elles peuvent être, on peut avoir, elles peuvent être proches de l'anus, donc de la marge anale, ou bien plus haute, on ne rentrera pas dans les détails, mais l'essentiel pour nous, c'est que vous reconnaissiez c'est quoi? Cet abcès anal, ou bien cette fistule anale, d'accord? Donc, elle va se manifester sous forme de quoi? Sous forme de tuméfaction, donc comme ici, on a une tuméfaction inflammatoire, donc rougeâtre, tendue, douloureuse de la marge anale, et on retrouve surtout chez le nourissant. Donc, à l'examen de la marge anale, donc si la maman vous dit qu'elle voit une petite masse, etc.

et tout, donc ça, à cet instant-là, c'est une, c'est un abcès anal, donc un abcès anal qui est dû à l'infection des canaux glandulaires périennes, d'accord? Donc, elle peut, elle commencera par une, cette tuméfaction inflammatoire, etc., et après elle va s'ouvrir, on aura l'issue de pus à travers ce petit point ici, d'accord? Et qui signe qu'elle est en train de se fistuliser avec un écoulement purulent. Donc, elle commence comme une masse inflammatoire, tuméfaction rouge, tendue, douloureuse chez le nourissant, après elle va se fistuliser et donc on aura l'écoulement purulent, et donc ça signe qu'on est passé de l'abcès à fistule anal. Et on pourra, et donc elle va communiquer, donc ce fistule anal va communiquer d'ici de l'extérieur, donc de l'extérieur jusqu'au niveau intranal, donc on peut même mettre un cilet comme ça, et ça signe qu'il y a une fistulisation entre l'extérieur et l'intérieur, d'accord? Donc entre la marge anal avec le canal anal intérieur.

Alors le traitement c'est quoi? En période aiguë, c'est un traitement antibiotique, donc on fait un traitement antibiotique, puisqu'on a une tuméfaction qui est d'origine infectieuse, donc on traite, et des fois on va inciser l'abcès, pourquoi? Parce que c'est la tuméfaction qui est douloureuse, donc il faut soulager l'enfant, on peut faire une incision d'abcès avec un traitement antibiotique jusqu'à ce qu'il y ait assèchement. Et lors de la fistulisation, il faut mettre à plat cette fistule, c'est ce qu'on a fait ici, donc on a enlevé le trajet fistuleux, d'accord? Ce qu'on appelle donc mise à plat de la fistule, ou bien une fistule au stomie. Et en général le problème est réglé, on n'a pas de problème.

Alors ici j'ai parlé des abcès ou des fistules anoxysants les plus fréquents, et qui ne font pas partie, et qu'on retrouve surtout chez le nourissant, et qui ne font pas partie d'une pathologie générale. Mais des fois, on va trouver, donc ces fistules anoxysants peuvent faire partie d'une maladie beaucoup plus grave, qui est de maladies inflammatoires, donc des maladies inflammatoires intestinales, notamment la maladie de Crohn, et qui peut être aussi, c'est le, qui peut être le signe, qui peut être le premier signe de la maladie de Crohn, d'accord? Mais c'est surtout ces fistules, on va les trouver chez les enfants beaucoup plus grands que les nourissants. La plupart ici chez les nourissants, les fistules anoxysants qui viennent après les abcès, donc c'est une infection des glandes, des canons glandulaires, et donc le traitement général, le traitement est rapidement, donc il y a assèchement après un traitement antibiotique,

et quand on enlève la fistule, le problème est réglé.

À côté de ces abcès et ces fistules anoxysants, on a la fissure anal. Alors c'est quoi la fissure anal? Fissure, c'est comme son nom l'indique, c'est une déchirure, déchirure longitudinale de la jonction cutanéomuqueuse de l'anus, d'accord? C'est une plaie, une déchirure, on a une déchirure, donc lors, c'est une déchirure, une plaie, qui va de la zone qui siège au niveau ici, donc de la jonction entre rectum et l'anus. Elle est provoquée par quoi? Elle est provoquée lors des passages d'estelle, d'accord? Elle est provoquée aussi par le grattage, quand on a les oxyures, c'est les enfants qui n'arrêtent pas de gratter, donc ils vont nous faire une fissure anal, ou bien par les celles qui sont dures lors de la constipation.

La plupart du temps, elle va siéger soit ici, donc dans ces zones radiaires comme ça, soit à midi, soit à 6 heures, d'accord? Donc la plupart du temps, c'est ici, où on aura les zones de la déchirure. Alors vous comprenez très bien que quand on a une déchirure au niveau de l'anus, donc on aura une douleur à chaque défécation. Chaque fois qu'il y aura des selles, l'enfant va avoir mal, à tel point qu'il va voir qu'il refuse d'aller à la selle, parce que chaque fois qu'il est dans la toilette, il a mal, donc il refuse d'aller à la selle, et donc ce qui fait qu'il peut aggraver sa constipation, et donc aggraver sa douleur lors de la prochaine selle.

On peut avoir aussi, donc une douleur à la défécation, on peut avoir aussi saignement après l'émission des selles, pas au cours des selles, comme dans l'hôpolite, donc l'hôpolite, on a dit, on a des saignements au cours de l'émission des selles, on a des selles qui sont striées de sang, ici, la fissure, on aura des saignements après le passage, pourquoi? Parce qu'on a eu aggravation de la fissure par le passage des selles. C'est très douloureux, et donc le traitement reposera essentiellement sur une régularisation du transit, avec normalisation de la consistance, c'est-à-dire qu'on va donner des traitements anti-constipants, qui contre la constipation, et il faut appliquer une pommade cicatrisante avec un anesthésiant, pour éviter qu'il y ait cette douleur à chaque défécation, et il faut savoir la retrouver cette fissure anale, par un examen systématique de la marge anale chez un enfant, parce que dans la mère, elle vous dit qu'il a mal, à chaque fois qu'il fait ses selles, il a mal, donc il faut aller examiner cette marge anale, déplacer cette marge anale, pour chercher cette petite fissure qui est très douloureuse chez l'enfant. En dernier, on va voir la dermite streptococcite, qui peut être un motif aussi fréquent de consultation en proctologie.

C'est quoi cette dermite streptococcite ? Donc dermite, c'est une inflammation du derme, qui est due à un gène, le streptocoque. Donc elle est due au streptocoque bêta-hémolytique, on la retrouve surtout chez des enfants entre 1 à 8 ans, surtout chez le garçon, et elle se manifeste par un petit placard, donc un placard rouge, écarlate, d'accord, qui peut être au départ, il est limité juste au marge anale, mais s'il n'est pas traité, il va s'étendre aux organes génitaux, et il aura des douleurs à chaque fois qu'il va à la selle, avec un prurite anal et même des rectoragies, d'accord, et s'il s'étend aux organes génitaux, il va s'étendre à toute la région périnéale et ça va être très très douloureux chez l'enfant. Donc le traitement, c'est des bêtalactamines pendant des jours, et il faut qu'il soit bien suivi, car des fois, mal suivi, il va récidiver.

(35:15 - 36:02)

En définitif, donc la proctologie, donc les motifs de consultation en proctologie pédiatrique, ils peuvent être multiples, ils peuvent être bénins, qui disparaissent une fois que le traitement est bien établi, donc que le diagnostic est bien fait, que le traitement est bien établi, ils peuvent aussi être le point de départ de certaines pathologies beaucoup plus importantes, donc il faut savoir poser les bons diagnostics et faire le bon examen, et ça reste quand même un motif de consultation, surtout chez les petits, c'est pour ça qu'il faut savoir bien examiner aussi la région anal et la région périnéale chez l'enfant, et qui doit faire partie d'un temps essentiel de l'examen de tout enfant. Merci.